



GUIDA PRATICA · PER DOCENTI E DIRIGENTI

Edizione 2025/2026 · Vol. 01

5 segnali di disagio in *classe*.

*Cosa osservare, cosa fare, quando chiedere aiuto.
Una guida operativa per chi lavora con i ragazzi.*

A CURA DI
Studio Psiche Holos · Brescia

PAGINE
8 · gratuita

EDIZIONE
A.S. 2025/2026

Dott.sse Ilenia Tagliaferro · Valentina Nicolai
Iscritte all'Ordine degli Psicologi della Lombardia

INTRODUZIONE

Quando un ragazzo chiede aiuto senza parole.

I docenti sono spesso i primi adulti a notare un cambiamento. Questa guida nasce per offrire un linguaggio comune e qualche strumento concreto.

Ogni anno, gli insegnanti italiani incontrano in classe ragazzi che mostrano segnali di disagio. La maggior parte di questi segnali **non sono crisi conclamate**, ma piccole variazioni quotidiane che, se riconosciute in tempo, possono evitare percorsi di sofferenza più lunghi.

Riconoscere non significa diagnosticare. Significa **osservare con attenzione, descrivere con precisione, e sapere a chi rivolgersi** quando qualcosa non torna. È un lavoro che spetta agli adulti che stanno accanto ai ragazzi tutti i giorni — e in cui un confronto con uno psicologo, anche solo informativo, può fare una grande differenza.

Questa guida raccoglie cinque dei segnali più frequenti riscontrati nelle scuole bresciane in cui collaboriamo. Per ognuno proponiamo: **cosa osservare, cosa potrebbe esserci dietro, cosa fare in classe, cosa evitare e quando rivolgersi a uno specialista.**

IN QUESTA GUIDA

- 01** Calo improvviso del rendimento e dell'attenzione
- 02** Isolamento sociale e ritiro dalle relazioni
- 03** Sintomi somatici frequenti
- 04** Ansia, attacchi di panico, rifiuto della scuola
- 05** Aggressività e comportamenti oppositivi nuovi

Importante. Questa guida è uno strumento di sensibilizzazione e orientamento. Non sostituisce in alcun caso una valutazione psicologica o psicodiagnostica condotta da professionisti qualificati. Se hai dubbi, parla con uno psicologo prima di trarre conclusioni sul singolo caso.

1

SEGNALE 01

Calo improvviso del rendimento e dell'attenzione

Quando un ragazzo che andava bene non riesce più a tenere il passo, e nessuno sa esattamente perché.



COSA OSSERVARE

- Voti in calo senza una causa apparente, anche in materie precedentemente gradite
- Difficoltà a mantenere la concentrazione per più di pochi minuti
- Compiti incompleti, dimenticati o non consegnati con sempre maggiore frequenza
- Apatia, sbadigli frequenti, fatica fisica visibile dalle prime ore



COSA POTREBBE ESSERCI DIETRO

- Disturbi del sonno, sovraccarico, stress cronico
- Difficoltà familiari o relazionali esterne alla scuola
- Inizio di un quadro depressivo, ansioso o di isolamento
- DSA (dislessia, discalculia) non diagnosticati che emergono con l'aumentare della complessità
- Episodi di bullismo o cyberbullismo subito



COSA PUOI FARE IN CLASSE

- Annotare in modo descrittivo (non giudicante) ciò che osservi nel tempo
- Confrontarti con i colleghi: il calo è generalizzato o circoscritto?
- Parlare con lo studente in modo riservato e a basso impatto: *"Ti vedo più stanco/a, va tutto bene?"*
- Comunicare con la famiglia in tempi rapidi, prima che la situazione si cronicizzi



COSA EVITARE

- Attribuire il calo a "svogliatezza" o pigrizia senza approfondire
- Sanzionare il rendimento prima di averne capito le cause
- Discutere il caso davanti alla classe
- Formulare diagnosi: *"Sei sicuramente depresso/a"* non aiuta nessuno



QUANDO RIVOLGERSI A UNO SPECIALISTA

Se il calo persiste per più di **4-6 settimane**, se compaiono altri segnali (somatici, ritiro, ansia), se la famiglia segnala difficoltà a casa, o se sospetti DSA / ADHD non identificati. Un confronto con uno psicologo scolastico aiuta a distinguere il fisiologico dal clinico.

2

SEGNALE 02

Isolamento sociale e ritiro dalle relazioni

Quando il banco resta progressivamente vuoto di voci, e il ragazzo si fa piccolo.



COSA OSSERVARE

- In ricreazione resta solo, in disparte, oppure si rifugia spesso in bagno
- Non viene scelto né cerca compagni nei lavori di gruppo
- Smette di partecipare a uscite scolastiche, gite, attività extracurricolari
- Nelle conversazioni di gruppo non interviene, ride poco, sorride raramente



COSA POTREBBE ESSERCI DIETRO

- Esperienze di esclusione, presa in giro, bullismo (anche online)
- Ansia sociale, fobia scolastica iniziale
- Depressione adolescenziale o disturbi dell'umore
- Difficoltà legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere non comprese
- Dispersione legata a contesti familiari fragili



COSA PUOI FARE IN CLASSE

- Riprogettare i gruppi di lavoro a rotazione, includendo lo studente in modo naturale
- Affidargli piccoli ruoli che lo valorizzino davanti ai pari (senza esporlo)
- Creare momenti di confronto a coppie o piccoli gruppi anziché plenarie
- Avvicinarti con discrezione, senza forzature o domande dirette davanti agli altri



COSA EVITARE

- Forzare l'inclusione: "Dai, vai con loro!" peggiora la sofferenza
- Esporre lo studente in classe per "sbloccarlo"
- Etichettarlo come "timido" o "chiuso", normalizzando il problema
- Aspettare che sia lui a chiedere aiuto: spesso non ne ha le parole



QUANDO RIVOLGERSI A UNO SPECIALISTA

Se l'isolamento è **persistente per più di 4-6 settimane**, se ci sono segnali di sofferenza fisica (pianto, irritabilità in casa), se compaiono pensieri o frasi di scoraggiamento, o se sospetti dinamiche di bullismo.

Non aspettare: l'isolamento è uno dei principali fattori di rischio per disturbi dell'umore in adolescenza.

3

SEGNALE 03

Sintomi somatici frequenti e ripetuti

Quando il corpo dice quello che la mente non riesce ancora a dire.



COSA OSSERVARE

- Mal di testa e mal di pancia ricorrenti, soprattutto la mattina o prima delle verifiche
- Richieste frequenti di andare in bagno, sensazione di nausea o vomito
- Stanchezza e affaticamento sproporzionati rispetto al carico
- Disturbi del sonno raccontati dalla famiglia (insonnia, incubi, risvegli notturni)



COSA POTREBBE ESSERCI DIETRO

- Ansia da prestazione e stress scolastico cronico
- Disturbi d'ansia generalizzata o attacchi di panico subclinici
- Espressione corporea di stati emotivi complessi (somatizzazione)
- Tensioni familiari o di coppia tra i genitori percepite dal ragazzo
- In alcuni casi, condizioni mediche reali da escludere prima



COSA PUOI FARE IN CLASSE

- Tenere un breve registro delle volte e dei contesti in cui si manifestano
- Notare se i sintomi compaiono prima di certe materie o prove specifiche
- Concedere brevi pause respiratorie senza farne un evento pubblico
- Segnalare alla famiglia in modo descrittivo, suggerendo una visita medica preliminare



COSA EVITARE

- Banalizzare i sintomi: *"È tutto nella tua testa"*
- Sospettare di simulazione: il dolore è reale anche quando l'origine è emotiva
- Negare l'uscita dall'aula sistematicamente per "principio educativo"
- Saltare la fase medica e attribuire tutto al disagio psicologico



QUANDO RIVOLGERSI A UNO SPECIALISTA

Una volta **esclusa la causa medica** con il pediatra o il medico curante, se i sintomi persistono e sono ricorrenti negli stessi contesti scolastici, una valutazione psicologica è indicata. **Non aspettare la diagnosi medica:** i due percorsi possono procedere in parallelo.

4

SEGNALE 04

Ansia, attacchi di panico, rifiuto della scuola

Quando entrare in classe diventa, nella testa o nel corpo, qualcosa di insostenibile.



COSA OSSERVARE

- Assenze ripetute, soprattutto in giornate di verifica o esposizioni orali
- Tremori, sudorazione, respiro corto, vertigini durante le prestazioni
- Pianto improvviso, difficoltà a entrare in aula la mattina
- Preoccupazioni anticipatorie ("E se sbaglio? E se non mi sento bene?")



COSA POTREBBE ESSERCI DIETRO

- Disturbo d'ansia generalizzata o disturbo di panico
- Fobia sociale, ansia da prestazione cronica
- Esperienze traumatiche legate alla scuola (umiliazioni, fallimenti pubblici)
- Pressioni familiari eccessive sul rendimento
- Inizio di un quadro di rifiuto scolastico (school refusal)



COSA PUOI FARE IN CLASSE

- Concordare strategie individuali (es. interrogazione programmata, prove scritte alternative all'orale)
- Creare un "segnale" silenzioso per uscire dall'aula in caso di crisi imminente
- Ridurre la pubblicità delle prestazioni (no voti letti ad alta voce)
- Coinvolgere la famiglia in un piano graduale di rientro se ci sono assenze



COSA EVITARE

- Forzare l'esposizione: "Devi superare la tua ansia" non funziona, peggiora il quadro
- Sanzionare le assenze prima di averne capito la natura
- Permettere l'evitamento totale: rinforza il problema nel medio termine
- Definirlo "viziato" o "manipolatore": il rifiuto scolastico è quasi sempre vera sofferenza



QUANDO RIVOLGERSI A UNO SPECIALISTA

Subito, se ci sono attacchi di panico conclamati, assenze superiori al 20-25%, o sofferenza acuta nel rientro a scuola. L'ansia e il rifiuto scolastico, presi in tempo, rispondono molto bene a interventi cognitivo-comportamentali; ma se cronicizzati diventano molto più difficili da risolvere.

5

SEGNALE 05

Aggressività e comportamenti oppositivi nuovi

Quando un ragazzo che era "tranquillo" inizia a esplodere, e non si capisce cosa lo abbia cambiato.



COSA OSSERVARE

- Reazioni emotive sproporzionate rispetto allo stimolo (rabbia improvvisa, pianto, gridi)
- Sfide aperte all'autorità del docente che prima non c'erano
- Scontri verbali o fisici con i compagni
- Atteggiamenti provocatori o di sfida costanti, anche su questioni minime



COSA POTREBBE ESSerci DIETRO

- Ansia o depressione mascherate da rabbia (più comune di quanto si pensi)
- Esperienze recenti di trauma, perdita, separazione genitoriale
- ADHD non diagnosticato — la difficoltà di regolazione emotiva è spesso un sintomo
- Esposizione a violenza familiare o ambiente domestico instabile
- Disturbo oppositivo-provocatorio (più raro, ma richiede valutazione)



COSA PUOI FARE IN CLASSE

- Mantenere la calma e abbassare il tono: l'escalation peggiora sempre
- Allontanare temporaneamente lo studente dalla situazione, senza umiliarlo
- Riprendere il dialogo solo dopo il rientro alla calma (mai a caldo)
- Documentare gli episodi: contesto, scatenante, durata, risoluzione



COSA EVITARE

- Sanzionare punitivamente senza prima comprendere la causa
- Confronti pubblici, urla, espulsioni "di pancia"
- Etichettare il ragazzo come "violento" o "irrecuperabile"
- Coinvolgere la famiglia in modalità accusatoria: spesso è già in difficoltà



QUANDO RIVOLGERSI A UNO SPECIALISTA

Sempre, se gli episodi sono ricorrenti e nuovi rispetto al passato. L'aggressività in adolescenza è quasi sempre la *punta dell'iceberg* di qualcos'altro: trauma, ansia, depressione, ADHD non riconosciuto. Una valutazione psicologica permette di leggere il sintomo e di costruire una strategia condivisa con la famiglia.

DA SOLI SI PUÒ, IN DUE SI FA MEGLIO

Quando il segnale diventa una *storia*, chiamaci.

Riconoscere è il primo passo. Costruire una risposta concreta — per il singolo studente o per l'intera classe — è il secondo. Possiamo farlo insieme.

Formazione docenti

DSA, BES, gestione di classi complesse, aspetti emotivi e relazionali.

Sportello e percorsi individuali

Spazi di ascolto e orientamento per studenti, famiglie, docenti.

Laboratori di gruppo

Bullismo, soft skills, motivazione, metodo di studio.

Prenota una *call gratuita* di 30 minuti.

Costruiamo insieme il progetto della tua scuola.

☎ 392 821 5608

✉ psicheholos@gmail.com

📍 Via G. Zadei, 60 · 25128 Brescia



PRENOTA

**Dott.ssa
Ilenia Tagliaferro**

*Psicologa clinica
Psicoterapeuta CBT in formazione*

**Dott.ssa
Valentina Nicolai**

Psicologa Scolastica